Disnea

FISIOPATOLOGIA · Clase 01 · sensación de falta de aire: del esfuerzo al reposo, de la ortopnea a la tromboembolia

1 · QUÉ ES LA DISNEA Y CON QUÉ NO CONFUNDIRLA

Disnea F1
sensación subjetiva de disconfort o falta de aire; surge con el esfuerzo

en reposo y súbita alarma por

Disnea de reposo y súbita
sospechar tromboembolia pulmonar, neumotórax o crisis de ansiedad

se confunde con

Fatiga F3
falta de energía; la orgánica empeora al final del día y la psicógena, en casa y por la mañana

no es lo mismo que

Astenia F2
debilidad con molestias indiferenciadas en reposo, por bajo débito cardiaco al músculo

según el esfuerzo se gradúa en

2 · CÓMO SE GRADÚA: DEL ESFUERZO AL REPOSO

Escalera de esfuerzo F4
1 fisiológica, 2 grandes esfuerzos, 3 medianos (caminar 100 m), 4 pequeños (vestirse), 5 reposo

en el último escalón aparece la

Ortopnea F5
impide el decúbito: se ahoga echado y se alivia sentado o de pie

si despierta tras dormir es

DPN F6
despierta tras dormir 3 horas o más; sugiere insuficiencia cardiaca izquierda

con patrón periódico se ve

Cheyne-Stokes F8
apnea de 10 a 60 s seguida de respiraciones que crecen y decrecen

aparece en

Causas de Cheyne-Stokes
insuficiencia cardiaca, HTA, tronco cerebral, insuficiencia renal, intoxicaciones

se mantiene por el

Ciclo F9
apnea, baja el O2 y sube el CO2, se estimula el centro respiratorio, respiración superficial-profunda-superficial y nueva apnea

lo explica el mismo mecanismo

3 · POR QUÉ FALTA EL AIRE: MECANISMOS

se produce por fallas de

Qué puede fallar
altura (poco O2), vía aérea, parénquima, pleura, tórax, diafragma, corazón, metabolismo, SNC, psique y músculos

si el origen es respiratorio avanza

Disnea respiratoria (obstrucción, parénquima, pleura): lentamente progresiva F15

si baja el O2 o sube el CO2 actúan

Quimiorreceptores
detectan menos O2 o más CO2 y avisan al centro respiratorio

avisan al

Centro respiratorio
ordena más trabajo de los músculos respiratorios: nace la sensación de falta de aire

se ve en la

ordena más trabajo a los accesorios

Músculos accesorios
tensos con el esfuerzo (imagen 3)

Imagen 1
pulmón con vía libre, pulmón obstruido con secreción y control nervioso

4 · CARDIACA: EL LÍQUIDO LLEGA A LOS ALVÉOLOS

Insuficiencia del ventrículo izquierdo F7
estenosis mitral, crisis hipertensiva, infarto agudo extenso

hace fallar al VI y eleva la

Falla el VI F10
sube la presión, se dilata la válvula, sube la presión auricular y se regurgita a las venas pulmonares

por la presión retrógrada pasa

Líquido a los alvéolos F10
salida de líquido al intersticio y alvéolos: edema pulmonar

da una disnea

Disnea rápidamente progresiva, con ortopnea y DPN F15

5 · EMBÓLICA: TROMBOEMBOLIA PULMONAR

ante ella lo primero es

Tríada de Virchow F11
estasis venosa, lesión endotelial, hipercoagulabilidad

favorece el

en reposo y súbita suele ser *si es parénquima o vascular puede ser*

Trombo en miembros inferiores F12
se desprende y viaja como émbolo al corazón derecho

al embolizar causa

Obstrucción de la arteria pulmonar F12
se liberan tromboxano y serotonina: vasoconstricción e hipertensión pulmonar

por la hipertensión pulmonar sobrecarga

Sobrecarga del VD F12
insuficiencia cardiaca derecha con congestión sistémica: hepatomegalia y ascitis

y se presenta como

Cuadro de TEP F13
disnea súbita en reposo, dolor pleurítico y taquipnea: hay aire pero no flujo

orienta a

Hipótesis más probable: tromboembolia pulmonar

por el esfuerzo se busca la postura

6 · QUÉ HACER ANTE LA DISNEA

Posición sentada F14
primer paso del tratamiento sintomático

luego se mide la

Medir la saturación de O2 F14
si es menor de 90 %, dar oxígeno

en paralelo se piden

Exámenes
según la hipótesis: radiografía de tórax, ECG, enzimas cardiacas y función renal

orientan el

Tratamiento específico: cardiaca, inotrópicos y vasodilatadores; neumonía, antibióticos y O2; asma, broncodilatadores y corticoides F14

concepto · complicación · ejemplo · signo · síndrome · causa · mecanismo · desenlace · técnica · diagnóstico · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clase 1 · Dr. Sotito — teoría del docente (= literatura)